PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA GESTANTE

1. OBJETIVO

Brindar la valoración oportuna y supervisión del estado de salud de las gestantes, puerperio, pacientes de ginecología que llegan al servicio de urgencias o remitidas desde otros servicios realizando una adecuada clasificación y priorización para para su atención, incluyendo cuidados neonatales y definición de conducta y/o tratamiento a seguir según su prioridad clínica y los recursos disponibles en la institución, disminuyendo el riesgo de muerte y complicaciones que pongan en riesgo la salud maternofetal.

2. Alcance

El procedimiento va dirigido a profesionales de medicina, enfermería y auxiliares de enfermería. Que forman parte del servicio de ginecología del hospital regional

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

de Moniquirá el cual está destinado a la atención del preparto, parto y recuperación del binomio madre - hijo además de enfocarnos en la prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo. Al igual de la atención oportuna de la alteraciones ya identificadas en la materna y neonatos.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

ID	Termino	Definición	Fuente
1	Gestante	Que lleva en el útero un embrión fecundado o un feto, período de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento.	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
2	Neonato	recién nacido desde el dia 0- 28	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
3	Puerperio	es el periodo que va desde el momento inmediatamente posterior del parto hasta los 35-40 días	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
4	**Trabajo de parto**	Conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, para la asistencia de las mujeres gestantes en los procesos fisiológicos y dinámicos del trabajo de parto, expulsión del feto vivo o muerto, con 20 o más semanas de gestación, alumbramiento y puerperio inmediato.	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
5	**Aborto**	terminación espontánea o provocada de una gestación antes de la vigésima semana (20), contando desde el primer día de la última menstruación normal, cuando el feto no es capaz de sobrevivir fuera del vientre materno, aproximadamente el feto pesa 500 gramos para esta edad gestacional (OMS)	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
6	**Trastornos hiperntesivos**	alteraciones hipertensivas que acompañan al embarazo determinan una complicación obstétrica frecuente y de notable morbimortalidad materna y perinatal	Guía de trastornos hipertensivos del embarazo
7	**Estrategia ISABEL**	Instrumento del ministerio de salud que permite garantizar las condiciones de calidad de la atencion para la emergencia	Ministerio de salud y protección social colombia

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

		obstetrica mediante la cualificacion de ls competencias de las IPS que atienden los eventos obstetricos en Colombia	

4. ENFOQUE DIFERENCIAL

4.1 Prestación de servicios de salud con enfoque diferencial

La prestación de servicios de salud en la ESE Hospital Regional de Moniquirá está enmarcada dentro del enfoque diferencial dadas las características individuales del usuario, su familia y la comunidad en general, promoviendo permanentemente la dignidad humana y la igualdad de condiciones, a través de la comunicación efectiva y la caracterización adecuada de la población que se beneficia con la prestación de nuestros servicios.
Cuando se habla de enfoque diferencial es el reconocimiento de esas características particulares en razón **de su edad, género, orientación sexual, grupo étnico y situación de discapacidad**, los cuales deben recibir un tratamiento especial en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencial y reparación integral.
Bajo este contexto la ESE estableció como población diferencial los siguientes grupos:

- Población de Adulto Mayor con patologías Crónicas
- Población Gestantes
- Población con discapacidad
- Población menos de 5 años
- Población LGTBI
- Población étnica.
- Población Afrodescendiente
- Población Privada de la Libertad
- Población Victima del conflicto Armado

Con el fin de velar por el cumplimiento de la política institucional de enfoque diferencial la Institución Promueve los siguientes compromisos:

MI COMPROMISO COMO COLABORADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ ES: Velar por la eliminación de actos de discriminación, diferencias

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

innecesarias, injustas y evitables en detrimento del estado de la salud, autoestima y supervivencia de nuestros usuarios.

POR GÉNERO Y ORIENTACION SEXUAL: Asegurar que las mujeres, los hombres y las personas LGTBI, tengan las mismas oportunidades para gozar de buena salud de acuerdo con sus necesidades y condiciones de vida sin señalamientos de ninguna clase.

POR ETNIA: Brindar trato digno y actitud amable a la población indígena, Afro descendiente, Población ROM (Gitanos), en igualdad de sus derechos para acceder a la prestación de los servicios.

POR CICLO VITAL: satisfacer las necesidades, sin sumar obstáculos adicionales a los que la sociedad ha creado a los adultos mayores, los niños y niñas, la población infantil a cargo del ICBF u otras instituciones y la población mayor en centros de protección

POR CONDICION DE VIDA: Respetar las creencias y costumbres de cada individuo cuando se está en periodo gestacional o en curso de transición o identificación de identidad de género.

POR SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD: Asegurar el apoyo y la atención preferencial de nuestros usuarios con algún tipo de situación limitante en nuestras IPS, evitando que su condición (Física, Mental o Sensorial) afecte el acceso, movilidad, seguridad y desarrollo de sus derechos durante la prestación de los servicios

POSICIÓN SOCIAL DESVENTAJOSA: Crear los medios que garanticen la seguridad física, emocional, sexual, social, legal de las víctimas, el apoyo a los esfuerzos por retomar el control de sus vidas y avanzar en los procesos de curación, justicia y reparación a la población en condiciones de desplazamiento forzado, menores desvinculados del conflicto armado, personas incluidas en el programa de protección a testigos y población desmovilizada o desplazada

.

Para todos estos grupos poblacionales debemos conocer, entender e informar a los pacientes los beneficios con que cuentan acorde a la normatividad vigente para su salud y bienestar. Las especificaciones por cada grupo se encuentran documentadas en el *“protocolo para la atención con enfoque diferencial”*

Caracterización de la atención con enfoque integral y diferencial

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

La atención diferencial e integral debe tener unas características especiales tales como:

1. Siempre brinde un trato respetuoso y diferencial: Dar un trato digno y respetuoso que tenga en cuenta las necesidades de cada persona permite crear una sociedad más inclusiva y brindar un servicio oportuno y adecuado a la población priorizada por la institución.

2. Sea un conocedor: Infórmese y prepárese para ayudar a crear una atención en salud más participativa, conociendo, al menos de manera general, las barreras que enfrentan los usuarios y población especial en cada uno del ciclo de atención.

3. Pregunte antes de ayudar: Identifique cuales son las habilidades y características especiales de cada población y persona antes de ayudar con el fin de identificar si la persona quiera recibir ayuda y así identificar cual es la mejor forma de ayudarle y respetar su autonomía e independencia.

4. No subestimar o exaltar sin razón: Una condición especial o característica especial de cada individuo no define la condición humana del mismo. Por lo tanto, estas personas no son más o menos que otras personas. Subestimar sus capacidades o exaltar sus logros “a pesar de su discapacidad”, acentúa las barreras existentes para su participación y goce efectivo de derechos.

5. Tenga en cuenta el lenguaje: Se debe activar la comunicación verbal y no verbal en cada uno de los momentos de verdad que se tiene con el usuario y su familia por eso las expresiones deben ser respetuosas e incluyentes.

- ***Escuche:*** Escuche siempre a las personas y permita que expresen sus necesidades. De ser necesario, deles el tiempo que requieran para hacerlo. Su conocimiento, escucha y empatía son las herramientas que le permitirán ayudarles a encontrar soluciones a sus necesidades
- ***Utilice herramientas:*** Recuerde que no existe una sola forma de comunicarse. Complemente su atención a las personas con discapacidad con el uso de herramientas de comunicación alternas como lápiz, papel, imágenes o ejemplos que le permitan comprender mejor su requerimiento.
- ***Disposición:*** Escuche, explique con calma y de forma sencilla, y evite comportamientos que puedan hacer sentir incómoda o maltratada a la persona con discapacidad

Rectifique: Verifique que la información suministrada al ciudadano con discapacidad ha sido efectivamente comprendida. Para esto solicite retroalimentación y, si es necesario, repita la información en un lenguaje claro y sencillo, manteniendo la exactitud y veracidad de ésta.

5 RECURSOS

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

5.1 Talento Humano

ID	Recurso		Cantidad
1	MEDICO ESPECIALISTA - GINECOBSTETRA		5
2	MEDICO ESPECIALISTA - PEDIATRIA		4
3	MEDICO GENERAL HOSPITALARIO		4
4	JEFE DE ENFERMERIA		4
5	AUXILIAR DE ENFERMERIA		4
6	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES		1
7	CAMILLERO		1
8	EQUIPO DE VIGILANTES O GUARDAS DE SEGURIDAD		2
8	AUXILAR ESTRATEGIA IAMII		

4.1. Equipos Biomédicos

ID	Recurso	Cantidad
1	Monitor de signos vitales (multiparámetros)	3
2	Monitor fetal	2
3	Doppler fetales	3
4	Termómetro	2
5	Glucómetro	1
6	Ecógrafo	1
7	Incubadoras	2
8	Pesa bebes	1
9	Equipo de succion	1
10	Desfibrilador	1

4.2. Medicamentos, Dispositivos Médicos o Insumos Requeridos

ID	Recurso	Cantidad
1	el consultorio de urgencias de ginecología cuenta con camilla, tensiómetro, doppler fetal, ecógrafo	1
2	sala de partos (1 camilla de atención de parto – cervocuna - monitor de signos vitales) carro de código azul y rojo, nevera de almacenamiento	1

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

3	sala de trabajo de partos cuenta con 4 camillas simples dividas con cortinas y una camilla externa numeraciones de 7-11	1
4	camas posparto 5 con numeraciones 1-5	1
5	camillas adicionales simples n 3, numeradas 13-14 -6	1

6. CONDICIONES GENERALES

ID	Condiciones generales
1	Todas las pacientes gestantes con prueba de embarazo positiva en sangre deberán ser valoradas por el servicio de urgencias ginecológicas sin necesidad de ser valorada en urgencias por medico general y se clasificará según la clasificación del triage socializado en el protocolo: “triage obstétrico y atención a la gestante” disponible en ALMERA
2	Todas las gestantes remitidas de otras instituciones ingresan mínimo como TRIAGE 2 a no ser que tengan patologías que las clasifiquen en TRIAGE 1 Según las directrices dadas por la ESTRATEGIA ISABEL desde la secretaria de salud de Boyacá y el medico de ginecología que recibe a la gestante diligenciará un formato donde se registre la lista de chequeo con verificación de manejo realizado por primer nivel (disponible en ALMERA)
3	La clasificación de TRIAGE es realizada por un jefe de enfermería de urgenicas que utilizara la herramienta creada para la atención de TRIAGE EN OBSTETRICIA , si la clasificación es TRIAGE 1 la paciente sera valorada en reanimación de urgencias hasta su estabilización ,si es TRIAGE 2 en adelante será valorada por el servicio de Ginecología .
4	Una vez ingresa la paciente en el servicio de Urgencias las etapas de digiturno, encuesta, el proceso de admisión deben ser generados de manera simultánea para generar los documentos administrativos que permitan el registro de la atención.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

5	Una vez realizada la clasificación del triage obstétrico Si se clasifica como triage 1 se ACTIVA EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA OBSTETRICA DESDE URGENCIAS (Ver protocolo de activación de equipo de respuesta rápida obstétrica – ESTRATEGIA ISABEL) El llamado al especialista de ginecología desde el servicio de urgencias se realizará desde el teléfono celular de REFERENCIA . La paciente debe ser estabilizada en el servicio de urgencias en sala de reanimación y posterior a la estabilización, y según indicación, se trasladada en camilla , monitorizada y acompañada por medico de urgencia / urgenciólogo y jefe de enfermería al servicio de ginecología o salas de cirugía según necesidad; Igualmente, la jefe enfermería debe entregar el triage obstétrico debidamente diligenciado en físico.
6	Al activar el EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA OBSTETRICA DESDE URGENCIAS el medico que recibe la paciente debe diligenciar la FICHA DE NOTIFIACION SUPERINMEDIATA DE LA EMERGENCIA OBSTETRICA y notificar a salud publica dada la importancia de la notificación dentro del tiempo establecido por el SIVIGILA , A estas pacientes desde urgencias se les deberá diligenciar el formato de UNIDAD DE ANALISIS (Disponible en ALMERA) para el respectivo análisis con el protocolo de Londres en los diferentes comités de seguridad del paciente y comité de morbilidad materna extrema de manera mensual para evaluar causas y realizar los respectivos planes de mejora en ALMERA
7	Cuando se requiera interconsulta desde el servicio de urgencias para valoración por el servicio de ginecología el médico solicitante la ordena la interconsulta desde dinámica y adicionalmente se comunica vía telefónica con el especialista de turno para comentar la paciente o con el servicio de ginecobstetricia para comentar interconsulta con especialista de turno, una vez valorada por el ginecobstetra y sí su conducta es hospitalizar a la paciente esta debe ser recibida en el servicio de ginecobstetricia según disponibilidad de camas .

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

8	La valoración de las pacientes de la urgencia se realiza en el consultorio de urgencias de ginecología donde se diligencia la respectiva historia clínica: con las siguientes características : - Registro de la clasificación de TRIAGE - motivo de consulta - anamnesis - registro de laboratorios infecciosos y STORCH y registro de ecografías que aporte la paciente con registro de (fecha de la ecografía , peso fetal ,percentil de crecimiento fetal , situación fetal , presentación fetal , localización de la placenta , liquido amniótico) entre otra información relevante de las ecografías - examen físico completo con registro de la altura uterina fetocardía y tacto vaginal - análisis del estado clínico de la paciente - plan de manejo médico - clasificación de riesgos estrategia Isabel / riesgo obstétrico / riesgo tromboembólico / riesgo social escala de herrera y hurtado / riesgo de preeclampsia / riesgo de código rojo / riesgo de depresión - registrar el método de planificación familiar al egreso - registrar el uso de ASA y CALCIO - registrar el deseo de planificación al egreso

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	- identificar los criterios para admisión y/o factores de riesgo a tener en cuenta, incluyendo los siguientes: - Atención del trabajo de parto - Parto pre término - Amenazas de aborto o abortos - Infecciones vaginales urinarias en los diferentes trimestres del embarazo - Puerperios con complicaciones
9	Durante la consulta en ginecobstetricia se solicita a la paciente y al familiar que se debe internar a la paciente con los siguientes elementos: Botella de agua grande, 4 pañales de adultos, dos tapabocas desechables, elementos de aseo personal y la pañalera con la primera muda, pañales y pañitos Se recomienda a la materna sin uñas pintadas, sin maquillaje, sin joyas y sin piercings . Todas las gestantes que ingresan a trabajo de parto tienen derecho a un acompañante permanente por estrategia IAMII previa firma de consentimiento informado de acompañamiento el cual debe ingresar a esta área con gorro, polainas y bata desechable. (CONSENTIMIENTO INFORMADO DE ACOMPAÑAMIENTO DISPONIBLE EN ALMERA)
9	La inducción de parto o manejo de su trabajo de parto está basado en resolución 3280 del ministerio de salud

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

10	Las condiciones clínicas para recibir pacientes en trabajo de parto son: - Bienestar fetal por monitoria - Embarazo mayor a 37 semanas con indicaciones medicas de inducción del parto. - Cambios cervicales con una dilatación mayor a 4 cm - Ruptura prematura de membranas - Embarazo a término de 40 semanas sin actividad uterina citadas para inducción de parto - Gestantes con pelvis favorables - Maternas con antecedentes materno-fetales de importancia entre otras hemorragias uterinas anormales, trastornos hipertensivos, diabetes gestacional con indicación de inducción de parto - Gestantes con alto riesgo psicosocial – rural disperso que no tengan la posibilidad de consultar de manera oportuna en la institución.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

11	En el servicio de ginecobstetricia se realizan las monitorias fetales tanto de consulta externa como derivadas de la atención de urgencias así como las ecografías de consulta externa y las de urgencias.
12	En el servicio de ginecología se hospitalizan los posoperatorios de las cirugías programadas de ginecología y obstetricia según disponibilidad de camas
13	El servicio de Ginecobstetricia cuenta con el equipo médico idóneo, la dotación, los equipos biomédicos para la atención de la gestante.
14	En el servicio de ginecología se realiza seguimiento de interconsultas intrahospiatalarias de posoperatorios, paciente ginecológicas y patologías de los diferentes trimestres del embarazo
15	Se considera fuga del paciente de urgencias o egreso no manifiesto cuando el paciente sin aprobación ni conocimiento del personal de salud se retira de la institución sin previo aviso pese a su condiciones o estado de salud .
16	Si la paciente manifiesta egreso voluntario por no aceptación del tratamiento se informa al servicio de trabajo social y Psicología los cuales notifican a comisaria de familia y bienestar en dado caso de complicaciones en el embarazo.
17	Es responsabilidad de la enfermera jefe asistir a las revisiones del carro de paro y codigo rojo según corresponda al turno, así como reportar y gestionar la reposición de los medicamentos, insumos y dispositivos que se gastan del carro de paro a la farmacia y reportar en la bitácora de entrega de turno las novedades que se presenten como pendientes, faltantes, pérdidas o averías.
18	Es responsabilidad de la jefe turno informar a la líder de enfermería del servicio las novedades que se presenten con el personal en cada turno, las necesidades de infraestructura, dotación, limpieza y desinfección, medicamentos y dispositivos médicos y demás dificultades y oportunidades de mejora que considere necesarias en el servicio.
19	Es responsabilidad de todos los integrantes del servicio de ginecología el reporte de los incidentes, eventos y acciones inseguras que afecten la seguridad del paciente y de los colaboradores del equipo de trabajo a través de la plataforma ALMERA disponible en la página web del hospital, posterior al evento obstétrico o complicación

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

20	A todos los casos de activación del equipo de respuesta rápida obstétrica de la estrategia ISABEL o las complicaciones obstétricas o neonatales derivadas de la atención se les deberá diligenciar el formato de UNIDAD DE ANALISIS (Disponible en ALMERA) para el respectivo análisis con el protocolo de Londres en los diferentes comités de seguridad del paciente y comité de morbilidad materna extrema de manera mensual para evaluar causas y realizar los respectivos planes de mejora en ALMERA

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

21	La auxiliar N 3 del servicio de ginecobstetricia será la responsable del diligenciamiento de la lista de chequeo de la estrategia ISABEL, la cual incluye el llamado telefónico a diferentes especialidades aplicando estrategia I.D.E.A.S , reportando la oportunidad de respuesta por cada servicio medidos por tiempos, esta debe ser medida y analizada en el comité de morbilidad materna.
22	La atención de pacientes con patologías ginecológicas deben seguir los lineamientos de ingreso, facturación, encuesta de clasificación en ruta de atención, valoración de triage, atención médica y definición de conducta desde el servicio de urgencias , y si requieren valoración por ginecología, se debe interconsultar al especialista y comentar la valoración a ginecólogo o medico de turno de manera telefónica siguiendo el protocolo de interconsultas institucional. Igualmente, el jefe de enfermería debe comentar la interconsulta con jefe de turno del servicio de ginecobstetricia para coordinar el traslado.
23	Es responsabilidad del jefe de enfermería del servicio de ginecobstetricia y neonatos verificar que se cumplan los lineamientos y horarios definidos para las rutas de recolección de residuos como la adecuada segregación de los mismos, ruta de alimentos hospitalarios tanto para la solicitud por medio de canales digitales como para la entrega, ruta de limpieza y desinfección la cual es solicitada a través de WhatsApp, ruta de entrega de medicamentos, ruta de ropa hospitalaria sucia y limpia a través del diligenciamiento de documento disponible en el correo institucional, entro otras
24	Todo el equipo de atención Ginecoobstetricia debe prestar trato humanizado, respetuoso y cordial en todos los casos sin excepción a cada uno de los pacientes del servicio de ginecobstetricia y neonatos; y brindar educación diaria a las madres sobre Lactancia Materna aplicando la estrategia de instituciones amigas de la mujer y la infancia con enfoque integral IAMII
25	El horario de entrega de información a los familiares y pacientes del estado y evolución de su salud es inmediatamente después de la revista médica diaria o posterior a las 10 am, evaluando su estado emocional y tramitando apoyo psicológico de ser necesario y será entregada en la mesa de información dispuesta por el servicio para la misma , asi también será registrada en el libro y carpeta de información para los familiares dispuesto en el servicio
26	Fortaleciendo la estrategia de instituciones amigas de la mujer y la infancia con enfoque integral IAMII , las pacientes en trabajo de parto tienen derecho a un acompañamiento permanente la cual es la persona mas

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

significativa para ellas, esto a la previa autorización de la gestante y firma del consentimiento informado para el acompañamiento diligenciado al ingreso al área de trabajo de parto.

Las pacientes en posoperatorio de cesárea tienen derecho al acompañamiento de la persona más significativa para ellas de dos horas en el servicio de ginecobstetricia posterior a su recuperación anestésica, esto en horarios nocturnos.

Las visitas de las pacientes en puerperio estarán en horarios de 10 am a 6 pm en horario continuo con restricciones institucionales por edad del acompañante y comorbilidades que pudieran presentar en el momento de realizar la visita cumpliendo protocolos institucionales.

27 Los criterios para remisión a mayor nivel de complejidad de las maternas que se atienden en el hospital regional de Moniquirá incluyen:

CRITERIOS	TIEMPO DE ESPERA PARA LA REMISIÓN	REQUERIMIENTO
RCIU de 37 semanas con pesos fetales menores a 2500 gr con bienestar fetal comprobado por monitorias fetales NST y / o ecografía obstétrica con perfil biofísico SIN cambios cervicales al examen físico	Comentada en CRUE y direccionada según la EPS para finalización de la gestación	Ambulancia medicalizada
RCIU de 37 semanas con pesos fetales menores a 2500 gr con sospecha de estado fetal no satisfactorio dado por Monitorias fetales CATEGORIA II persistente o CATEGORIA III y/o alteración ecografía obstétrica con perfil biofísico	Inmediato por requerimiento de **UCI Neonatal**	Ambulancia medicalizada
RCIU de 37 semanas con pesos fetales menores a 2500 gr con bienestar fetal comprobado por monitorias fetales y / o ecografía obstétrica con perfil biofísico CON cambios cervicales al examen físico dados por dilatación > 3 cm	Inmediato por requerimiento de **UCI Neonatal**	Ambulancia medicalizada

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	Trabajo de parto pretérmino entre 36 y 37 semanas con dilatación menor a 3 cm con bienestar fetal comprobado por monitoria fetal, se **solicitará concepto escrito de pediatría por el peso estimado fetal,** sí pediatría considera que no se puede atender en la institución se iniciará trámite de remisión a institución con **UCI NEONATAL**	Tiempo de espera máximo de 4 horas, si presenta progresión de cambios cervicales > 4 cm o sospecha de estado fetal no satisfactorio se enviará en traslado primario dada la no **disponibilidad de uci neonatal**	Ambulancia medicalizada
			Ambulancia medicalizada

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	Embarazo a término entre 37 y 39 semanas con una cesárea previa / dos o más cesáreas previas con ecografía que reporte placenta de localización anterior que no tengan Doppler de inserción placentaria, con monitoria con bienestar fetal NST sin evidencia de trabajo de parto con cérvix cerrado con indicación de finalización de la gestación y que consulte los días que no se tiene disponibilidad de realización de Doppler de inserción placentaria . dado el alto riesgo de acretismo placentario	Comentada en CRUE y direccionada según la EPS para finalización de la gestación, siempre verificando bienestar fetal por monitorias	
	Embarazo a término entre 37 y 39 semanas con una cesárea previa / dos o más cesáreas previas con ecografía que reporte placenta de localización anterior que no tengan Doppler de inserción placentaria, con monitoria con SOSPECHA DE ESTADO FETAL NO SATISFACTORIO , CAMBIOS CERVICALES > 4 CM con indicación de finalización de la gestación y que consulte los días donde no se tiene disponibilidad de realización de Doppler de inserción placentaria realizado por medicina materno fetal dado el alto riesgo de acretismo placentario	Traslado primario	Ambulancia medicalizada
	Gestantes que cursen con diagnóstico de preeclampsia con características de severidad en embarazos antes de las 37 semanas (pretérmino) con indicación de finalización de la gestación, con bienestar fetal dado por monitoria fetal y / o perfil biofísico sin cambios cervicales al tacto vaginal	Comentada en CRUE y direccionada según la EPS para finalización de la gestación Tiempo de espera máximo de 6 horas	Ambulancia medicalizada
	Gestantes que cursen con diagnóstico de preeclampsia con características de severidad en embarazos antes de las 37 semanas (pretérmino) con indicación de finalización de la gestación, con sospecha de estado fetal no satisfactorio, cambios cervicales > 3 cm o deterioro materno que requiera finalización de manera inmediata	traslado primario dada la **no disponibilidad de uci neonatal**	Ambulancia medicalizada

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	Embarazo de 37semanas o más con Sospecha de Acretismo placentario por Doppler de inserción placentario positivo en gestante con bienestar fetal con monitoria NST sin dinámica uterina, sin cambios cervicales al	Comentada en CRUE y direccionada según la EPS para finalización de la gestación Tiempo de espera máximo de 12 horas	

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

tacto vaginal con indicación de finalización de la gestación		
Embarazo pretérmino menor de 37 semanas o a término 37 semanas o más con Sospecha de Acretismo placentario por Doppler de inserción placentario positivo en gestante con sospecha de estado fetal no satisfactorio, dinámica uterina por monitoria fetal o cambios cervicales D> 1 cm con indicación de finalización de la gestación (alto riesgo de acretismo placentario o morbimortalidad materna y fetal)	traslado primario	Ambulancia medicalizada
Gestantes con placenta de previa antes de las 37 con peso fetal estimado < 2500 gr en trabajo de parto con dilatación < 3 cm	T Traslado primario	Ambulancia medicalizada
Trabajo de parto pretérmino en embarazos entre 34 y 36 semanas con cambios cervicales – dilatación > 3cm **Se verificará bienestar feta y peso fetal y se comentará con pediatría si pediatra autoriza parto en la institución se atiende el mismo**	si el pediatra no autoriza parto se remitirá en traslado primario dada la **NO disponibilidad de UCI Neonatal**	Ambulancia medicalizada
Trabajo de parto pretérmino en embarazos entre 34 y 36 semanas cambios cervicales – dilatación < 3 cm con bienestar fetal y monitoria NST S	Según requerimiento de manejo en institución con disponibilidad de UCIN Comentada en CRUE y direccionada según la EPS Si inicia trabajo de parto, dinámica uterina o progresión de cambios cervicales se solicitará traslado primario.	Ambulancia medicalizada
Trabajo de parto pretérmino en embarazos menores a 34 semanas con cambios cervicales – dilatación > 3cm	traslado primario dada la NO disponibilidad de UCI Neonatal	Ambulancia medicalizada
Preeclampsia severa sin importar la edad gestacional con requerimiento de manejo por medicina materno fetal o unidad de alta dependencia obstétrica con bienestar fetal comprobado por monitoria fetal	Comentada en CRUE y direccionada según la EPS para manejo por tercer nivel	Ambulancia medicalizada
gestantes que requieran valoración por medicina materno fetal urgente o ecografía urgente por materno fetal y estemos entre los días jueves a martes	Comentada en CRUE y direccionada según la EPS para manejo por tercer nivel	Ambulancia medicalizada

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	Pacientes que requieran manejo integral por Ginecología Oncológica por presentar marcadores tumorales positivos con masas anexiales o abdominales sugestivas de procesos neoplásicos	Comentada en CRUE y direccionada según la EPS para manejo por tercer nivel	Ambulancia básica
28	Está prohibido el ingreso de alimentos al servicio a menos que tenga permiso por parte del médico de turno previa firma del permiso escrito .		
29	En los cambios de turno se debe cumplir el protocolo de entrega y recibo de turno, presentándose cada integrante el equipo de quedará a cargo de su atención, previo lavado e higienización de manos (ver protocolo de lavado de manos y entrega de turno) Para la entrega de turno de los médicos generales, esta entrega se debe realizar en la cabecera del paciente previo lavado de manos e higienización entre paciente y paciente y lavado de manos cada 3 pacientes.		
30	Las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaran en el servicio de ginecología independiente de la vía de ingreso de la paciente (ver protocolo de IVE INSTITUCIONAL)		

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ID	Actividad	Responsable	Observaciones

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

1	En cada turno al recibir o entregar turno se diligenciará por parte del personal del servicio de ginecología el tablero de la estrategia ISABEL	Equipo ginecología Verificador: ginecólogo de turno / jefe de turno	En este tablero quedan divididas las funciones dentro de cada turno por si se activa el equipo de respuesta rápida en la estrategia ISABEL y en el código rojo de la siguiente manera ginecólogo de turno : coordinador Apoyo : medico del servicio Asistente 1 : jefe enfermería

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			asistente n 2 : auxiliar de sala de partos asistente 3 : auxiliar de neonatos
2	Generar digiturno cuando evidencia la gestante	Auxiliar de experiencia al usuario	En el servicio de urgencias
3	Realizar de Triage obstétrico y escala de alerta temprana (ver anexo Triage obstétrico)	Enfermera del servicio de TRIAGE	Jefe de enfermería Capacitado en atención de triage obstétrico Diligenciar el Excel de Triage obstétrico y escala de alerta temprana y llevar el triage impreso al servicio de ginecología para la atención
4	GESTANTE CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA	Atención por médico general ginecología	Toda gestante con sintomatología respiratoria se debe valorar en el servicio de ginecología previa entrega de tapabocas / N95 por el jefe de triage para el traslado. La atención de la gestante se realizará en el consultorio designado para atención a gestantes respiratorias. La atención por médico general de ginecología debe ser completa enfocada en el motivo de consulta y en el momento de descartar

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			patología respiratoria tipo COVID Se debe realizar exámen físico completo con toma de tensión arterial, medición de altura uterina con registro en DINAMICA y tacto vaginal Clasificar los riesgos obstétricos y la necesidad de activación de equipo de respuesta rápida según MEOWS y TRIAGE OBSTETRICO Definir manejo y solicitar los exámenes dejando registro en la historia clínica. Según necesidad de valoración por ginecología se solicitará la interconsulta según protocolos institucionales o se dará egreso directamente del servicio de urgencias ginecológicas. Se recomienda que la gestante tenga todos sus exámenes de controles prenatales, y puede estar acompañada por un familiar durante todo el proceso de la atención por estrategia IAMII

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

5	Realizar apertura de la historia clínica	Auxiliar de Ciclo económico interno	Luego de la realización de la clasificación de triage y triage obstétrico el acompañante de la gestante deberá dirigirse a la ventanilla de facturación de urgencias para realizar la apertura de la historia clínica.
6	Verificar en la ventanilla del ciclo económico derechos de afiliación y hacer la activación de la HC en dinámica	Analista de Ciclo económico interno	En caso de que el paciente tenga inconvenientes administrativos tales como estado de afiliación inactivo por mora o desafiliación, sin documentos, sin afiliación, se debe ingresar como particular y en las siguientes 6 horas antes de terminar el

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			turno notificar al líder de facturación dentro del ciclo económico y resolver la situación administrativa. Posteriormente se debe hacer la actualización en dinámica para facilitar el proceso administrativo de facturación.
7	Traslado de la gestante al segundo para la atención por Ginecología	Camillero / auxiliar de enfermería	Posterior a la clasificación de TRIAGE obstétrico, si la gestante es clasificada como TRIAGE 2 o más, la gestante es trasladada al segundo piso de ginecología para la atención y será registrada en el libro de atenciones . Si se clasifica como TRIAGE 1se debe valorar en el servicio de urgencias – en reanimacion (Ver protocolo de activación de equipo de respuesta rápida obstétrica – estrategia ISABEL)
	Valorar la consulta de atención de urgencia de la gestante según, tiempos del TRIAGE OBSTETRICO Y ESCALA DE ALERTA TEMPRANA	Médico general con entrenamiento en ginecología	Se realiza en el servicio de ginecóloga las 24 horas del día Se recomienda que la gestante tenga todos sus exámenes de controles prenatales , y puede estar acompañada por un familiar durante todo el proceso de la atención por estrategia IAMII

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

8			Realizar examen físico completo con toma de tensión arterial , medición de altura uterina con registro en DINAMICA auscultación de fetocardia según edad gestacional y tacto vaginal a todas las gestantes Clasificar los riesgos obstétricos y la

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			necesidad de activación de equipo de respuesta rápida según MEOWS y TRIAGE OBSTETRICO Definir manejo y solicitar los exámenes dejando registro en la historia clínica
9	**Si la escala de alerta temprana genera y MEOWS** > 4 puntos o es un TRIGE 1 se activa el EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA	Activación por parte del médico general que atiende la urgencia y /o el ginecólogo de turno	Este equipo está confirmado por • Médico general con entrenamiento en ginecología • Médico especialista de ginecología de turno • Médico anestesiólogo de turno • Médico especialista en pediatría de turno • Médico especialista en unidad de cuidados intensivos de turno • Médico especialista en medicina interna de turno • Médico especialista en cirugía de turno • Jefe líder de enfermería de

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			urgencias / uci / salas de cirugía / ginecología • Líder de laboratorio clínico • Líder de farmacia • Líder de referencia y contra referencia La notificación al grupo de se realizará vía WhatsApp con La estrategia I.D.E.A.S. (Ver protocolo de activación de equipo de respuesta rápida obstétrica disponible en ALMERA) y la responsabilidad de la llamada al equipo de respuesta será de la Auxiliar N3
10	Activar cadena de llamado para respuesta presencial	Médico general / auxiliar 3 servicio ginecología o auxiliar designado en los servicios de urgencias – salas de cirugía.	Simultáneamente a la notificación del grupo de WhatsApp con la estrategia I.D.E.A.S el médico que activa el grupo de respuesta rápida, da orden a la auxiliar 3 del servicio de ginecología

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			designado en el tablero de equipo de respuesta rápida presente en el servicio de ginecobstetricia o auxiliar designado en los servicios de urgencias para activar la cadena de llamado según la disponibilidad del tablero de la estrategia ISABEL siguiendo la información de la estrategia I.D.E.A.S (Ver protocolo de activación equipo de respuesta rápida obstétrica)

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

11	Realizar Estabilización o reanimación inicial con aplicación de escala de riesgo obstétrico y aplicación de listas de chequeo para emergencia obstétrica. Según patología de ingreso de la paciente. Uso de. **Infografía Emergencia Obstétrica UFA-A-74** cargado a la Plataforma ALMERA , en el stand de enfermería y publicado en el servicio de ginecología y urgencias.	Equipo de respuesta rápida (presencial)	Atención según protocolos institucionales con mínimo tiempo de respuesta presencial en el día de 7 am a 7 pm de 5 minutos dada la presencialidad del especialista y en noche de 15 minutos teniendo en cuenta la disponibilidad al llamado de los especialistas
12	Aplicar la escala Clasificación del riesgo	Médico general / ginecólogo/ jefe enfermería	Se clasifica el riesgo - Obstétrico - Trombo embolico - Social - De caída - Riesgo de sepsis: se marca con cinta AMARILLA en tablero de identificación historia clínica y

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			carnet de enfermería - Riesgo de hemorragia posparto: se marca con cinta AZUL en tablero de identificación historia clínica y carnet de enfermería - Riesgo tromboembólico se marca con cinta VERDE en tablero de identificación historia clínica y carnet de enfermería - Riesgo de preeclampsia: se marca con cinta NEGRA en tablero de identificación historia clínica y carnet de enfermería Estas clasificaciones deben quedar consignadas en la historia clínica de ingreso de la atención obstétrica y en las notas de evolución del servicio de ginecología.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

13	Valoración según patología para evaluar conductas, Clasificar el riesgo materno fetal e identificar el manejo según periodo de embarazo	Ginecólogo de turno	Realizar examen físico completo con toma de tensión arterial , medición de altura uterina con registro en DINAMICA auscultación de fetocardia según edad gestacional y tacto vaginal a todas las gestantes Clasificar los riesgos obstétricos y la necesidad de activación de equipo de respuesta rápida según MEOWS y TRIAGE OBSTETRICO Definir manejo y solicitar los exámenes dejando registro en la historia clínica Definir hospitalización o manejo en tercer nivel según criterios de remisión institucional.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

14	Explicar a la gestante el plan de parto y las recomendaciones si se encuentra en trabajo de parto y realizar el diligenciamiento del consentimiento informado para la atención del parto vaginal y / o instrumentado y / o cesárea de urgencia Realizar el diligenciamiento del consentimiento informado para el acompañamiento del familiar según la estrategia de Hospitales Amigos de la mujer y la infancia Integral	Medico de turno / Ginecólogo de turno	Si no se encuentra en trabajo se resalta cual es la patología que genera su consulta en el servicio de urgencia y se indica manejo ambulatorio o intrahospitalario Si la paciente se encuentra en trabajo de parto previo al egreso a sala de partos, se debe firmar por parte de la paciente en consentimiento de la atención del parto donde se explican los riesgos y beneficios de la atención del mismo Se realiza el diligenciamiento del consentimiento informado para el acompañamiento del familiar según la estrategia de Hospitales Amigos de la mujer y la infancia Integral

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

15	Definir según indicación vía de parto cesárea en las siguientes indicaciones	Ginecólogo de turno	CESAREA ELECTIVA : Intervención programada que se realiza antes del inicio del parto en gestantes con patología materna o fetal que contraindique o desaconseje un parto por vía vaginal. Deberán programarse a partir de la semana 39 de gestación para disminuir el riesgo de morbilidad respiratoria fetal. Se deberá programar en semana 39 por consulta externa y deben hacer el proceso instutucional para valoración por anestesiologia y salir en el programa quirurgico del día indicado si la paciente ingresa por urgencias puede tener una espera entre 2 a 3 horas previa verificacion de bienestar fetal

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			INDICACIONES DE CESÁREA ELECTIVA: - Presentación de nalgas, transversa u oblicua que no este en trabajo de parto - Sospecha de Macrosomía fetal que no este en trabajo de parto - Cesárea iterativa: >2 cesáreas previas (riesgo de rotura uterina del 1,4%) programada sin trabajo de parto - Antecedente de rotura uterina (programar en sem 38) sin trabajo de parto - Gestantes sometidas a cirugía uterina previa uterina previa con entrada a cavidad (miomectomía) sin trabajo de parto - Cesárea previa con incisión uterina corporal vertical o clásica o histerotomía transversa ampliada en "T": riesgo de ruptura uterina del 1.6% y 6%

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			respectivamente sin trabajo de parto - Placenta previa asintomatica programar cesárea electiva a las 37-38 semanas si ha presentado al menos un episodio de sangrado se debe programar cesárea electiva a las 36-37 semanas previo doppler de insercion placentario negativo. - Infecciones maternas: condilomas acuminados que afecten extensamente el canal de parto. Pacientes VIH+, Lesiones activas de herpes genital (ver protocolo específico: "Infecciones Torch y por parvovirus B19 en la gestación). - Patología médica materna que desaconseje parto vaginal (cardiopatía severa, riesgo AVC…). - En algunos casos de prematuridad, CIR y gestaciones múltiples: dependerá de las circunstancias

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			individuales de cada caso -Una cesárea anterior y deseo materno de nueva cesárea sin trabajo de parto - Cesárea a demanda: la paciente solicita la realización de cesárea electiva sin intento de parto vaginal, no presentando ninguna contra indicación clínica para el mismo. CESAREA EN CURSO DEL PARTO se realiza durante el curso del parto, por indicación materna, fetal o mixta. Se incluyen: desproporción pélvico-fetal, fracaso de inducción, distocia de dilatación o de descenso y parto estacionado. No existe riesgo inminente para la madre ni el feto. ** este tipo de procedimientos puede tener una espera de dos horas (2) desde la definición de la cesárea previa

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			verificación de bienestar fetal hasta la extracción fetal *** causas : - distocia de progresión del parto o de dilatación, que se puede producir en diferentes fases del parto - Trastornos de la fase latente: dilatación < 4cm. o Fracaso de inducción: se considerará cuando, tras 12 +/-3 horas de inducción con Oxitocina I.V., con DU adecuada (3-5 contracciones/10 minutos o 200-225 UM en un período de 10 minutos) no se hayan alcanzado condiciones establecidas de trabajo parto (dilatación cérvix ≥ 4cm). - Trastornos de la dilatación: dilataciones entre ≥ 4cm y hasta 10cm (fase activa del parto). o Parto estacionado: se considerará que el parto está estacionado cuando, una vez iniciada la fase activa

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			de parto (dilatación cérvix ≥ 4cm) y con DU adecuada presente, no se producen cambios en las condiciones obstétricas después de 4 horas en nulíparas y 3 horas en aquellas gestantes que hayan tenido uno o más partos por vía vaginal previos. - Trastornos del periodo expulsivo: una vez alcanzada la dilatación completa. o Desproporción pélvico fetal: se diagnosticará cuando, en situación de dilatación completa, dinámica activa de parto y pujos activos, el punto guía de la presentación no llegue al tercer plano tras un periodo de tiempo que dependerá de la paridad y la analgesia: ▪ Sin analgesia epidural: 2 horas en multíparas y 3 horas en primíparas. ▪ Con analgesia epidural: 3 horas en multíparas y 4 horas en primíparas. CESAREA URGENTE

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			Es aquella que se realiza como consecuencia de una patología de la madre o del feto, en la que se sospecha compromiso del bienestar fetal (profilaxis pérdida del bienestar fetal). Puede ser anteparto o intraparto y se recomienda la finalización del embarazo de forma rápida. El tiempo seguro entre el diagnóstico y el inicio de la cesárea no debe superar los 30 minutos desde la indicación del procedimiento hasta la extracción fetal (estándar internacional) Las indicaciones más frecuentes son: - Sospecha de riesgo de pérdida de bienestar fetal MONITORIA ACOG II PERSISTENTE - Sospecha de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			- Sospecha de ruptura uterina. - Inestabilidad hemodinámica materna. - feto en podalico en trabajo de parto en fase activa - cesárea anterior antes de los 18 meses en trabajo de parto en fase activa - cesárea iterativa (mas de dos cesáreas) en trabajo de parto en fase activa. CESAREA EMERGENTE se indicará en situaciones en las que exista un riesgo vital para la madre y/o el feto La extracción fetal se tendrá que realizar en <15min indicaciones - Monitoria ACOG III - Ruptura uterina - prolapso de cordón umbilical -desprendimiento prematuro de placenta normoinserta,

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			- placenta previa con hemorragia que comprometa el estado hemodinámico de la paciente y embolia del líquido amniótico. - expulsivo prolongado - instrumentación fallida
16	Instalar la paciente en área de trabajo de parto identificar su periodo y fase del trabajo de parto. Entregar al paciente los elementos asignados para su atención, forma de utilizarlos y su ubicación (camilla, ropa hospitalaria, elementos como: pato, pisingo, riñonera) e indicar *el procedimiento de custodia de pertenencias}*	Ginecólogo, médico de turno jefe de enfermería o equipo de ginecología	Toda atención de la gestante debe tener registro en DINAMIA con los riesgos obstetricos y el registro de la escala de MEOWS La inducción y el manejo manejo de su trabajo de parto esta basado en resolución 3280 del ministerio de salud
17	Diligenciamiento de la escala de alerta temprana obstétrica en físico	Jefe enfermeria / auxiliares de enfermeria	A todas las gestantes que ingresen a la institución se les debe diligenciar el seguimiento de alerta temprana con los signos vitales en el formato institucional al color y si presenta

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			alguna alerta con cambios de color amarillo o rojo , se debe notificar al médico de turno para activar el equipo de respuesta rápida obstétrica o realizar vigilancia estricta de la gestante.
18	Explicar a la gestante y familiares de cada uno de los procedimientos a realizar u conductas de cambios en plan de trabajo de partos según evolución materno fetal. De forma detallada se explica a	Ginecólogo y Medico de turno , jefe de enfermería	Estos procedimientos y conductas no solo se ejecuta en paciente en trabajo de parto, sino también a las gestantes que presentan

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	paciente la posibilidad de refuerza de trabajo de parto con oxitócicos o manejo analgésico si lo desea.		amenazas de trabajos pre términos u otras patologías relacionadas con el embarazo Comunicar al paciente y/o familiares posibles riesgos y complicaciones evidenciadas por bienestar fetal insatisfactorio que puedan alterar el ciclo vital del producto
19	Explicar al paciente y a sus familiares o acompañante los procedimientos que se van a realizar, riesgos, posibles complicaciones, beneficios y alternativas que se presentan los cuales están consignados en el consentimiento informado que el paciente y/o acompañante o familiar deben firmar y donde se	Enfermera Jefe	Para el correcto diligenciamiento, archivo se deben seguir los lineamientos *del procedimiento consentimiento informado*

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	acepta o se rechaza la realización de los tratamientos o procedimientos		
20	Tramitar o gestionar interconsultas, a través de dinámica gerencial y comunicar a laboratorio, imágenes diagnósticas con cada una de las áreas correspondientes	Medico de turno Jefe de enfermería	Para la gestión de los laboratorios e imágenes diagnósticas se consideran oportunos si se realizan antes de las 3 horas una vez es confirmado al laboratorio y de acuerdo a los lineamientos definidos en el *procedimiento de atención del laboratorio* El tiempo de interconsulta con otras especialidades como: medicina interna, ortopedia, pediatría, ginecología, urología, neurocirugía, entre otras no debe superar las 4 horas o menos dependiendo de la disponibilidad y ocupación de los especialistas dentro de la institución. Las interconsultas con especialidades

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			que no se encuentren disponibles en la institución se deben acudir al llamado telefónico por parte del médico tratante. La respuesta a la interconsulta para aquellas especialidades que se encuentren en la institución con disponibilidad de agenda debe ser respondida en menos de 4 horas de 7 am a 7 pm y despues de las 7 pm se responderan las interconsultas de las urgencias vitales .
21	Tramitar y gestionar en la farmacia los medicamentos que hayan sido autorizados por el médico	Jefe de enfermería y Auxiliar de enfermería	El auxiliar de enfermería debe trasladarse a la farmacia y solicitar los medicamentos y dispositivos médicos por cada paciente inmediatamente son autorizados por el médico
22	Gestionar de acuerdo a la orden médica por cada paciente las dietas hospitalarias durante la estancia	Enfermera jefe	Realizar solicitud de dietas por paciente al servicio de alimentación hospitalaria cumpliendo con los horarios de solicitud

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			y novedades presentadas.
23	Indagar nuevamente al paciente sobre antecedentes farmacológicos antes de la administración de medicamentos para disminuir los eventos adversos, como reacciones alérgicas.	Auxiliar de enfermería	Auxiliar de enfermería
24	Administrar medicamentos según las indicaciones médicas antes o después de la toma de ayudas diagnosticas de laboratorio e imágenes diagnósticas y/o recomendaciones de preparación de toma de muestras o ayudas diagnósticas.	Enfermera jefe	Se debe registrar o cargar en el sistema o software de dinámica todos los medicamentos, dispositivos médicos e inmediatamente son administrados al paciente
25	Realizar el traslado del paciente al laboratorio o radiología *según el procedimiento de realización de ayudas diagnósticas .*	Camillero de turno / auxiliar de enfermería	Dejar consignado en la hoja de enfermería los datos completos, estado general del paciente, los procedimientos realizados, las posibles complicaciones, los cuidados de enfermería y la conducta a seguir por el área médica

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

26	Gestionar o validar directamente con las diferentes áreas la disponibilidad de los resultados de las ayudas diagnósticas de laboratorio, imágenes diagnósticas o	Médico de ginecología	El médico debe llamar a las diferentes áreas tales como: laboratorio, imágenes diagnósticas, especialistas de las

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	interconsultas según corresponda		interconsultas a través del teléfono interno o intercomunicador. Si los resultados de imágenes diagnósticas y laboratorios solicitados superan las 3 horas se debe tramitar la hospitalización y se comunica al servicio que lo reciben los resultados pendientes.
27	Entregar los resultados de ecografías al Médico tratante por parte del camillero, donde se deja registrado la hora y nombre de la persona que lo recibe.	Camillero de turno / auxiliar de laboratorio / auxiliar de Radiología	Los resultados de tomografías y rayos x serán cargados al sistema desde el área de imágenes diagnósticas según aplique y el médico tratante es el encargado de hacer seguimiento a la gestión de dichos resultados
28	Verificar que se hayan cargado correctamente en el software los medicamentos administrados, laboratorios, ayudas diagnósticas, interconsultas realizadas durante la atención en urgencias antes del cierre de la Historia clínica por parte del médico en caso de que se autorice la salida del paciente	Enfermera Jefe de ginecología	Esta actividad se debe realizar para validar el cierre de la historia clínica

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

29	Evaluación de escala de BISHOP cervical para inducción del trabajo de parto .	Medico de turno / Ginecólogo de turno	Posterior a valoración de la pelvis y evaluación del BISHOP cervical se decidirá por el ginecólogo de turno manejo con oxitócicos vs maduración cervical con prostaglandinas. Si se decide manejo con oxitocina se realizará inducción con oxitocina a dosis bajas de la siguiente manera : 4 u de oxitocina en 500 cc de SSN al 0.0 % iniciar a 30 cc / hora aumentar cada 30 minutos 15 cc / hora hasta llegar a 120 cc / hora o regularizar dinamica uterina con un máximo de 8 horas de infusion , posterior a esto se suspenderá y se iniciará al día siguiente por 8 horas máximo DOS días , si posterior a manejo DOS días de oxitocina a 120 cc / hora por 8 horas no presenta cambios cervicales se considera Inducción fallida y se finalizara la gestación por vía alta (cesárea). Si presenta BISHOP no favorable para inducción < 6 se dará manejo con prostaglandinas , en la

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			institución contamos con misoprostol de 25 mcg para administrar de la siguiente manera : Administrar 25 mcg de misoprostol intravaginales y revalorar en 6 horas para evaluar progresión cervical si no presenta cambios cervicales se indicara segunda dosis de misoprostol 25 mcg, previa monitoria fetal NST CATEGORIA I, si presenta monitoria PTC no colocar misoprostol , si se coloca segunda dosis de misoprostol se indica revalorar en 6 horas , si a la revaloración cervical persiste sin cambios cervicales se indicara tercera dosis de misoprostol 25 mcg , previa monitoria fetal NST CATEGORIA I , si presenta monitoria PTC no colocar misoprostol * Se revalorara 6 horas posterior a la tercera dosis de misoprostol para definir respuesta , si presenta dilatación > 2 cm o bishop favorable para oxitocina > 6 se indica inicio de manejo con oxitocina según protocolo previa hidratacion ,y monitoria fetal ACOG I Si no presenta cambios

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			cervicales se considerada inducción fallida y se finalizara la gestación por via alta (cesarea)

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

30	Realizar seguimiento a la evolución de las fases del trabajo de parto y una vez se identifica dilatación de 10 cm se traslada la paciente a sala de partos	Ginecólogo y Medico de turno, jefe de enfermería.	Realizar vigilancia estricta del trabajo de parto Toma de monitoria fetal cada 4 horas impresa y reportada en DINAMICA monitorización fetal intermitente Realizar el correcto diligenciamiento de la partograma desde 6 cm de dilatación , y nota medica en DINAMICA cada 2 horas desde fase activa del trabajo de parto o durante la vigilancia cuando el estado de salud de la paciente lo requiera En todas las notas de evolución relacionar los riesgos obstétricos y el sistema de alerta temprana MEOWS Es necesario identificar las alteraciones en el trabajo de parto que nos indiquen cesárea de urgencias para

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			trasladar a sala de cirugía
31	Diligenciar tablero de riesgos previos al parto	Auxiliar enfermería de trabajo de parto	Antes de ingresar al trabajo de parto ,la auxiliar de trabajo de parto debe diligenciar el tablero de parto seguro donde se clasifican los diferentes riesgos y se registran posteriormente los datos del recién nacido , también se registran la cantidad de gasas compresas y material que se utilizara en la atención del parto , asi como el recuento final de instrumental y material
32	Atender el parto normal en la sala de partos	Ginecólogo y Medico de turno, jefe de enfermería y auxiliar de enfermería	Validar Condiciones normales como: pelvis favorable, bienestar fetal por seguimiento de frecuencia cardiaca y estabilidad hemodinámica Una vez se obtiene el recién nacido se solicita al laboratorio la realización hemoclasificación.

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			A las 24 horas de nacido se solicitara el tamizaje metabólico del recién nacido que incluye TSH Si fallece la materna o el neonato se debe terminar el procedimiento. Si el fallecido es el neonato se debe enviar el feto a estudio de necropsia clínica obligatoriamente con el proveedor contratado . En este caso se debe explicar al paciente y familiares el procedimiento a seguir y diligenciar el *Formato Autorización Autopsia, Disposición de Fetos* Si el fallecimiento es de la materna se debe enviar a necropsia en los casos en los cuales no es definida claramente la causa de la muerte o por solicitud de los familiares

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

33	Comunicar con empatía y lenguaje humanizado a los familiares en caso Abortos, óbitos fetales, muertes neonatales realizar las anotaciones pertinentes en la Historia clínica y trasladar a sala de cirugía para respectivo estudio patológico o necropsia clínica fetal	Médico de Ginecología	Se indicara llenar formato de necropsia clínica o estudio anatomopatológico según diagnóstico identificado Para las pacientes que cursan con un evento de morbilidad materna extrema deben ser valoradas intrahospitalariamente e por psicología para manejo integral .
34	Realizar procedimientos de puerperio	Ginecólogo y Medico de turno, jefe de enfermería y auxiliar de enfermería y pediatra	Incluye vigilancia de 2 horas con monitorización permanente con majeo de analgésico y cuidados de sangrados y alimentación de dieta normal. En todas las notas se deben registrar los riesgos obstétricos y al escala de alerta temprana MEOWS
35	Realizar el certificado de nacido vivo	Medico de turno,	Entregar a la mamá el certificado una vez se identifica su

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			hemoclasificación y toma de TSH
36	Informar telefónicamente y hacer seguimiento al servicio de vacunación sobre la necesidad de aplicar vacunas de recién nacido dentro del servicio de pos parto	jefe de enfermería de ginecología y auxiliar estrategia IAMII	Desde la estrategia IAMII se realiza el seguimiento a asistencia a las citas de control , vacunación y signos de alarma del puerperio
37	Trasladar a la paciente a sala de recuperación o unidades de post parto para vigilancia hasta completar las 24 horas pos parto	Auxiliar de enfermería	Toma de signos vitales cada 15 minutos las primeras dos horas, estos signos vitales se deben registrar en la hoja de escala de alerta temprana y activar el equipo de respuesta rápida si presenta algún signo de alarma vigilar sangrado, vigilar patrón respiratorio de neonato y lactancia materna, Registrar en historia clínica y evaluar alteración de signos con escala de alerta temprana

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

38	Garantizar el metodo de planificacion de eleccion para la gestante previa asesoría para la elección de acuerdo con los criterios de elegibilidad de la OMS y elección de la usuaria .	Médico general / ginecólogo / salas de cirugía	Se entrega a todas las gestantes un folleto de métodos de planificación haciendo énfasis en métodos de larga duración con criterios de elegibilidad de la OMS con firma de recibido del mismo

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			Se garantiza la administración y colocación del método de planificación elegido por la paciente antes del egreso. Para las pacientes que desean planificación definitiva con pomeroy , y tienen su parto en el día antes de las 3 de la tarde, se debe cargar la boleta del procedimiento y realizar llamado telefónico al servicio de cirugía para que sean programadas al siguiente día . Para las pacientes con parto en la tarde o en la noche y deseo de pomeroy, se carga la boleta del procedimiento y se avisa telefónicamente a salas de cirugía para que sea realizado al siguiente día durante el programa. En todos los casos en la revista de la mañana se debe verificar el

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			procedimiento y el ayuno de la paciente
39	Entregar información a la familia sobre el binomio madre e hijo y permitir el acompañamiento en el puerperio de 10 am a 6 pm	Médico de turno	Se debe indicar a la familia la necesidad de recolectar los documentos necesarios y tramitar la inclusión del recién nacido en el grupo familiar o afiliación a la EPS Se debe registrar la información en el libro de información
40	Registrar en la historia clínica y ejecutar las órdenes médicas.	Ginecólogo y Medico de turno, jefe de enfermería y auxiliar de enfermería y pediatra	Registrar en cada folio lo correspondiente a las notas de enfermería y al cumplimiento de las ordenes
41	Dar salida a la paciente registrando evolución, materna y valoración por pediatría de neonato, se resaltan signos de alarma, recomendaciones, charlas instructivas de cuidados neonato y lactancia materna	Médico de turno	
42	Garantizar el egreso seguro de las gestantes con moribilidad materna extrema Por estrategia ISABEL se debe garantizar que las gestantes que presentaron	Ginecología / salud publica /	No se dará egreso a la gestante hasta que tenga los medicamentos necesarios en casa para manejo de su patología de base ejemplo glucómetros,enoxap

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	eventos de morbilidad materna extrema o las gestantes de alto riesgo		arina . antihipertensivos entre otros (ver anexo procedimiento egreso seguro ginecologia)

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

43	Se debe garantizar el ergreso del binomio con cita para pediatria – medico general o ginecologia según corresponda por estragegia IAMIII	Agendamiento – ciclo económico interno	La jefe de enfermería o auxiliar de enfermería previo al egreso , debe llevar la historia a ciclo económico interno para que realicen el respectivo proceso de facturación y generen las citas para cumplir con la estrategia IAMII y la 3280 . Control por pediatria y medico general entre 3- 5 dias Control por ginecologia medicina materno fetal o especialidad según lo requerido o maternas con

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

			eventos de morbilidad materna extrema en los primerios 7 dias Los días de lunes a sábado después de las 5m y los domingos y festivos después de la 1 pm , se avisara por medio de un mensaje al líder de agendamiento para que las pacientes egresen con sus respectivas citas .
44	Capacitar a la paciente en los lineamientos de IAMII con una charla que incluye continuar esquema de vacunación, lactancia materna exclusiva, crecimiento y desarrollo	Jefe de enfermería y auxiliar de enfermería IAMII	Se registra información en carpeta de la estrategia IAMII
45	Devolver medicamentos o insumos por personal de enfermería si se requiere y realiza la nota de enfermería en la hoja de enfermería	Jefe de enfermería	Jefe de enfermería

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

46	Verificar antes de la salida el retiro de catéteres venosos, sondas, drenajes.	Auxiliar de enfermería	En caso de presentarse complicaciones postquirúrgicas y que requieren continuar con el uso en casa de sondas vesicales o drenajes se debe dar recomendaciones y signos de alarma para reconsulta por urgencias
47	Dar salida a la paciente registrando en el software de dinámica, se resaltan signos de alarma,	Médico de turno	Cargar al sistema dinámica en inventarios los medicamentos, insumos y

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	recomendaciones, charlas instructivas de cuidados		dispositivos, interconsultas realizadas a cada paciente antes del cierre de la HC
48	Realizar los reportes de seguridad del paciente, SIVIGILA, código verde, morbimortalidad materna. Unidad de análisis de casos de morbilidad materna extrema entre otros según aplique a la valoración del paciente.	Médico de turno / ginecólogo de turno	Este reporte debe ser inmediato siguiendo los lineamientos definidos en las fichas técnicas y protocolos de obligatorio reporte y cumplimiento los cuales son objeto de auditoría.
49	Las gestantes que ingresen remitidas de consulta externa (por médico general o ginecólogo) deben ser llevadas a urgencias por la auxiliar de consulta externa y realizar el proceso de TRIAGE OBSTETRICO desde urgencias	Auxiliar consulta externa	Las gestantes que ingresen remitidas de consulta externa (por médico general o ginecólogo) deben ser llevadas a urgencias por la auxiliar de consulta externa y realizar el proceso de TRIAGE OBSTETRICO desde urgencias y se realiza la atención de la paciente de urgencias según este procedimiento .
50	Entregar al servicio de facturación los registros derivados de la Historia	Auxiliar de enfermería	

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	clínica completos o pizarra para soporte de facturación y entrega al archivo físico de HC.		
51	Facturar los servicios prestados en Ginecología y emitir paz y salvo	Analista CEI	Se puede facturar correctamente si solo si todos los cargues y la HC están correctamente diligenciados; de lo contrario debe informar a la jefe de enfermería y médico de turno para que corrija las inconsistencias presentadas
52	Solicitar la firma del paciente en la factura como soporte de su atención y entrega del paz y salvo.	Analista CEI	Indicar al paciente la salida y la entrega del paz y salvo del paciente a la salida con el guarda de seguridad
53	Explicar al paciente los riesgos, complicaciones y alternativas que se pueden ocasionar a su estado de salud, en caso de que el paciente solicite la salida voluntaria en contra del concepto médico tratante.	Médico tratante	Se debe solicitar la firma del formato alta voluntaria especificando los riesgos específicos para el embarazo
54	Registrar en la Historia clínica los casos de fuga del paciente, los antecedentes. Si es un paciente con enfermedad mental se debe avisar los detalles de la fuga a la familia, guarda de seguridad, a experiencia del usuario y si	enfermera jefe y médico tratante de urgencias	

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	aplica a la Psicóloga y/o psiquiatra para valoración del caso y prevenir posibles complicaciones a la comunidad o sus familiares.		
55	Egreso de la paciente del servicio de ginecología	Auxiliar de enfermería	Posterior al paz y salvo dado por la paciente al personal de enfermería , la paciente es llevada a la salida por el personal de enfermería , el paz y salvo se entrega al egreso a portería .
56	Posterior al egreso de la paciente se debe Solicitar el respectivo aseo y desinfección de la unidad	auxiliar de enfermería	Jefe de enfermería / auxiliar de enfermería

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.